

	IMPRESIÓN DE HISTORIA CLÍNICA NEUROPSICOLOGÍA						
	Historia # 00013				Fecha De Impresión: 18-11-2025 17:45:30		
Datos Personales							
Nombre:	BLANCA YOMARI GUTIERREZ FUENTES	Sexo Biológ.:	M	F. Nacimiento:	2012-01-14	Edad	13 Años, 10 Meses, Y 4 Días
Identificación:	TI - 1063491507	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ESTUDIANTE
Correo Electrónico:	Olgarivera2010@hotmail.Com - 1063491507			Dirección:	CALLE 7 # 3-78 BARRIO LA INMACULADA EN CHIMICHAGUA		
Departamento:	CESAR	Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana	
Empresa:	Particular						
En Caso De Emergencia Llamar A:		OLGA RIVERA - Parentesco (madre)					

Apertura Neuropsicología del 2025-10-23 15:12:54: 13 años, 10 meses, y 4 días

DATOS GENERALES
Código de consulta No se ha seleccionado un código de consulta
Motivo de consulta Paciente refiere, casi no salgo ya, las personas me señalaban, mi mama esta desbastada.
Enfermedad actual Paciente refiere que el 3 de octubre del 2025, estuvo en el cementerio en una cita con un Yefersón Rolon Bayona, de aproximadamente 16 años de edad, agrega que él le pidió que le hiciera sexo oral arrodillada, a lo que ella accedió, durante la escena sexual Yefersón la toma duro de la cabeza, lo que la paciente describe como “ me estaba ahogando”, argumenta que ella no sabia que la estaban grabando cuando se esta ahogando se da cuenta que la graba y le pregunta que para que el video, luego de eso Yeferson le pide que se coloque de espalda, sintiendo temor, lo que hace que salga corriendo del lugar por miedo a que le hiciera daño. Agrega que al inicio se sintió traicionada, devastada, señalada por los demás compañeros lo que afecto la autoestima, agrega que ha intentado no pensar tanto en el tema, reconoce que su madre es una persona respetada y querida en el municipio lo que hace que muchas personas la estigmaticen por lo acontecido. Agrega que no entiende por que en la institución educativa hablaron primero con Jefferson y nunca con ella, refiere “a los dos nos suspendieron, pero a mí no me dijeron nada de volver a clases, después a los días llaman a mi madre a decirle, he estado en proceso con psicología, a mi no me gusta hablar del tema, he llorado en silencio, llevo un mes conociéndome con él. La paciente dice “el grado el video y se lo llevo, el me dijo que dijera que el video lo había publicado un amigo de él, cuando le reclame, me entere después que su madre trabaja en puteadero, me siento señalada, ha sido muy difícil. Para mí y mi madre”.

ANTECEDENTES	
Médicos Personales	
Quirúrgico No Reporta	Traumáticos Otro
Medicación No Reporta	Paraclínicos No Reporta
Hospitalizaciones No Reporta	Patología No Reporta
Tóxicos	

ANTECEDENTES	
Prenatales	
Edad De La Madre En El Embarazo No Reporta	Enfermedades De La Madre No
Único Embarazo No Reporta	El Embarazo Fue Controlado Por Atención Médica Si
Uso De Planificación En El Momento Del Embarazo Si	Estado De La Madre Durante El Embarazo No Reporta

ANTECEDENTES	
Natales	
Tipo De Nacimiento Cesarea	Causa De La Cesárea NA
Uso De Maniobras De Reanimación Si	Peso Al Nacer No Reporta
Talla Al Nacer No Reporta	Llanto Al Nacer Si

ANTECEDENTES
Posnatales

Hospitalizaciones Recién Nacido No Reporta	Desarrollo Psicomotor
--	------------------------------

ANTECEDENTES

Desarrollo Psicomotor

Control Cefálico	Rolado
Sedente Solo	Gateo
Bípedo Sin Ayuda	Marcha
Lenguaje Verbal	Lenguaje Verbal Fluido

ANTECEDENTES

Médicos Familiares

Depresión No Refiere	Ansiedad No Refiere
Demencia No Refiere	Alcoholismo No Refiere
Drogadicción No Refiere	Discapacidad Intelectual No Refiere
Patológicos No Reporta	Otros

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa

Durante la entrevista, la paciente, quien cursa noveno grado y ocupa el primer puesto académico en su institución educativa, manifiesta haber sido víctima de matoneo escolar previo a los acontecimientos recientes. Refiere que, tras la divulgación de un video con un estudiante de décimo grado, comenzó a ser señalada, estigmatizada y menospreciada por parte de sus compañeros y miembros de la comunidad educativa. Explica que esta situación afectó significativamente su bienestar emocional y académico, derivando finalmente en su expulsión de la institución, dado que los hechos ocurrieron mientras portaba las prendas de vestir institucionales.

Historia laboral

No reporta

Historia familiar

La paciente convive con su madre, conformando una familia nuclear caracterizada por una relación funcional y estable. Se observan lazos afectivos cercanos, adecuados niveles de comunicación y cohesión en las relaciones familiares. La dinámica familiar se describe como armoniosa, con presencia de apoyo mutuo y acompañamiento emocional. La paciente comparte con su entorno familiar y social costumbres y prácticas culturales comunes, mostrando buen nivel de integración tanto a nivel interno como con la comunidad. Se evidencia un adecuado nivel de conciencia familiar, una estructura organizada y relaciones sociales funcionales, lo que favorece su adaptación y sentido de pertenencia dentro del núcleo familiar y comunitario.

Historia social

A partir del evento vivido, la paciente ha limitado significativamente sus salidas y participación en espacios sociales, manifestando sentimientos de señalamiento y rechazo por parte de su entorno. Su familia atraviesa una situación de crisis emocional, dado que perciben que su intimidad ha sido vulnerada y que han sido objeto de comentarios directos e indirectos de tipo despectivo por parte de personas de la comunidad. Asimismo, se han presentado manifestaciones de hostilidad hacia la madre, quien ha recibido observaciones y juicios negativos relacionados con la situación. Estas experiencias han repercutido de manera significativa en el estado emocional y autoestima de la paciente, quien expresa sentimientos de vergüenza, tristeza y retraimiento social, evidenciando un proceso de afrontamiento aún en curso

Historia socio-afectiva

La paciente ha manifestado la presencia de ideas suicidas en tres ocasiones posteriores al evento traumático relacionado con la publicación del video, siendo la última ocurrencia el domingo 19 de octubre. Refiere dificultades en su autoestima, expresando que no se percibe atractiva ni valiosa, lo que la ha colocado en una situación de vulnerabilidad emocional y susceptibilidad a la manipulación. Se observa un pensamiento de tipo catastrófico, acompañado de impulsividad emocional y manifestaciones de tristeza profunda, señalando que en varias ocasiones llora en silencio al recordar lo sucedido. Además, reporta alteraciones en el sueño con dificultad para conciliar el descanso, pérdida del apetito y marcada afectación en su bienestar emocional general. En el momento de la evaluación, se identifica un alto riesgo de conducta suicida o pasaje al acto, por lo cual requiere seguimiento clínico constante y acompañamiento psicoterapéutico especializado orientado a la contención emocional, fortalecimiento de la autoestima y prevención del riesgo.

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica No reporta
Intervención neurológica No reporta
Intervención neuropsicológica Observación directa Historia clínica Examen mental Test proyectivo de familia Test proyectivo de machover Test de depresión de Beck

EXAMEN MENTAL

Examen Mental Paciente con adecuada presentación personal, se muestra alerta, motivada, entusiasta, inadecuada higiene postural, orientada auto y alopsiquicamente, lenguaje y pensamiento fluido, bradillaica, bradipisquica, hipoprosexia, juicio y raciocinio normal pero con alto nivel de facil manipular, inteligencia aparente normal, no restricciones en la locomoción, se muestra colaboradora. CONCLUSIONES.

La paciente presenta una afectación significativa del estado de ánimo, caracterizada por síntomas depresivos moderados, con puntuación de 40/63, derivados del evento traumático relacionado con la publicación del video. Se evidencian pensamientos de desesperanza, alteraciones en el sueño (insomnio de conciliación), pérdida del apetito y disminución de la autoestima, acompañados de ideación suicida activa y alto riesgo de vulnerabilidad emocional.

Durante la evaluación, la paciente se muestra inocente, sensible y emocionalmente afectada, manifestando tristeza no solo por las consecuencias personales del evento, sino también por el impacto emocional que este ha generado en su madre, quien igualmente ha visto comprometida su estabilidad emocional y autoestima.

En conjunto, los hallazgos sugieren la presencia de un cuadro depresivo de moderada severidad, con alto riesgo de conducta suicida, lo que requiere intervención psicológica inmediata, seguimiento continuo y acompañamiento familiar orientado a la contención, apoyo emocional y fortalecimiento del vínculo madre-hija.

RECOMENDACIONES

Se recomienda terminar curso de forma virtual debido a los señalamientos que pueden afectar en mayor medida la autoestima.

Se recomienda en lo posible tomar acciones que restringas el acceso del joven con la paciente ya que puede colocarla en riesgo de vulnerabilidad.

Necesidad de acompañamiento por psicología clínica debido a la clara afectación en el sueño, apetito, estado de ánimo.

Debido a la significativa afectación en el estado emocional de la paciente, asociada a un cuadro depresivo derivado del escarnio público, la estigmatización, los señalamientos y el matoneo, se recomienda a la Comisaría de Familia y demás entidades competentes realizar los procesos de entrevista, evaluación, acompañamiento y seguimiento en el lugar de residencia de la menor, con el fin de preservar su integridad emocional y física, garantizando un entorno seguro y contenedor, dado el alto riesgo de pasaje al acto identificado durante la valoración.

Ciclos del Sueño Desde el evento casi no duerme por las noches, insomnio de conciliaición.
Apetito Desde el evento a reducido el apetito.
Actividades de Autocuidado Conservadas

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA
Impresión Diagnóstica (CIE 10 - DSM-V): F321 - EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Impresión Diagnóstica Relacionada 1 Z615 - PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL ABUSO SEXUAL DEL NINO POR PERSONA AJENA AL GRUPO DE APOYO PRIMARIO
Establecido por primera vez

PLAN DE INTERVENCIÓN
Plan de Intervención
Objetivo General
Objetivos Especificos
Sugerencias e Interconsultas
Observaciones y Recomendaciones



Jainer E. Guzmán Vega
Psicólogo - M.G Neuropsicología
T.P 123096
U.S.B. - Medellín

DR. JAINER GUZMAN

Tarjeta Profesional: 123096